

OCR · 全量重排版

人际关系发展疗法

图片范围：001.jpg—050.jpg，含补充第 021 页 | 自动识别并轻量校订

源文件说明：重复图片 045.jpg 已去除

目录

第一章 我的孩子怎么就是孤独症了？

孤独症的诊断标准	003
诊断过程是什么样的？	004
诊断不能单纯靠经验	005
诊断的意义是什么？	005
何谓高功能、低功能？	006
干预过程中家长不应有的心态	009

第二章 我的孩子是孤独症，到哪儿治？

两大流派	012
ESDM 的‘坑’	013
何谓功能性疗法？	014
国内的‘鱼龙混杂’	015
ABA 的背后，我们要懂的……	016
何谓 PRT？	017
何谓生物疗法？	018
感统 & ALP	018
如何判断机构好坏？	019
这三座大山你不翻过去就不要谈脱帽	020
为什么要选 RDI？	021
一定要给孩子做‘拼盘’	022
一定要了解共患病……	023

第三章 只有把孩子变成‘机器’才行？

安坐、应名和听指令的背后是什么？	025
低功能的孩子更适合发展疗法	027
一定要搭建仿真小环境	028
何谓自我意识？	028
不怕基础差，就怕还在弯路绕	029
孤独症孩子的核心缺陷是什么？	031

第四章 我的孩子过了黄金期就没救了？

不要纠结所谓的黄金期	033
一定要关注‘窗口期’	034
如何捕捉和抓住窗口期？	035
一直在路上，一直有希望	036

第五章 我的孩子是孤独症，他会好吗？

《深夜妈妈谈》的创办初衷	037
用大龄案例来解读‘一日孤独症，终身孤独症’	037
我们的最终目标是什么？	039
两件值得关注的事情	039
究竟要不要百米冲刺？	041

第六章 条件反射型还是自我驱动型——你想要什么样的孩子？

你让孩子靠什么面对未来的不确定性？	042
动态智能是面对不确定性的能力	043
用一个故事解读动态智能	044
无条件的爱和溺爱的区别是什么？	044
过度指令、过度补偿……	045
如何让孩子感觉到自己在成长？	046
RDI 教给家长的……	046

第一章

我的孩子怎么就是孤独症了？

在我的工作中，遇到过很多家长，其中不仅包括刚被诊断出孤独症的孩子的家长，还包括那些孩子已经干预了两三年的家长。他们很难直面孩子患“孤独症”这一事实，或者采取了各种“正确”的干预方法但收效甚微。

对于这一类家长，解决问题很重要的一点是理解孤独症。就拿孩子生病来说，如果孩子发烧了，你做的第一件事肯定是查找病因，然后对症下药。但是对于孤独症孩子的家长来说，在孩子被确诊的那一刻，往往就慌了神。

很多家长会跳过前面的理解孤独症这一步（其实是很重要的一步），直接问“该怎么办”。有的家长会听别人介绍或者自己上网搜索哪个方法有效，然后就带着孩子一头扎进去了。但实际上，家长缺乏的是先停下来想一想孤独症到底是什么，我的孩子到底是怎么回事，这个病（或问题）是如何影响到孩子的。只有从这些角度出发，你才能做出正确的选择。如果选择的干预方法不恰当，会浪费孩子宝贵的早期干预的时间。

每个孤独症孩子的表现都是不同的。在我的直播间里，有不少家长问过我这样的问题：孩子小时候很早就会说话了，但是随着年龄的增长，慢慢地语言能力又丧失了。其实这是一种倒退型孤独症的表现。

就拿我的两个双胞胎儿子来说，他们差不多在1岁的时候，还可以牙牙学语，但在1岁半以后就完全没有语言了（当时我怀疑他们是智力障碍或者聋哑症）。在他们五六岁的时候，开始重新学习发音，我真的是掰着儿子的嘴教他们发出一个又一个音的。然而所有的付出都是值得的，我还记得那个难忘的时刻——他们说出了有意义的词语——“大鱼”（当时我正带着儿子们在千岛湖旅游，他们看到了很多好看的鲤鱼）。

说到倒退型孤独症，它实际上是一个全方位的退化，不只是表现在语言的退化上。如果孩子单单是语言退化，那么我建议家长先从环境中去找原因：是不是孩子在发展进程当中，他的能力跟环境不匹配，从而激发了他症状的产生？

在美国精神病学会（American Psychiatric Association, APA）颁布的DSM-5诊断新标准里面，提到孤独症有很多的表现会在幼年时期呈现，如果这些表现是后来才呈现的，那是不是说明孩子就肯定不是孤独症？其实不然，这可能是由于孩子的障碍状况不严重或者所处的环境支持度比较高，所以症状没显现，在碰到后来的环境支持和能力不匹配的时候，障碍被激发出来，从而出现了相应症状。

出生后6个月对孩子的成长来说是个重要的分水岭。这个时候典型发育的孩子表现出成长性需求，会主动探索周围的世界；而孤独症孩子会固守在自己的稳定性需求里，即他喜欢的是固定的、不变的东西，这样才能让他感觉是安全的。（家长如果想真正特别完整地了解 RDI 视角下孤独症到底是什么，以及它是怎样产生的，可以看一下我们 RDI 的课程。）

说白了，孤独症的特质，其实我们每个人身上都有，只不过没有达到诊断标准和影响身体功能的程度。比如说我吧，我其实也有很多很刻板的地方：我每天从家里出门时必须摸门框，而且必须是胳膊肘的某一个特定的部位碰到门框，不这样我就过不去。

在这里我想先叮嘱大家一句，在孤独症儿童的干预方面，我们真的可以少走弯路、少花冤枉钱。现在干预机构非常多，信息也很庞杂，我们要学会理性地分辨。这也是我想把自己这么多年一路走来的收获和心得分享出来的原因，在这里我更多的是孤独症孩子妈妈的角色，是一个过来人。

我希望，当家长发现孩子有异样或者孩子确诊后，你先明白孩子到底怎么了，从孩子的角度去看孤独症是如何影响到你的孩子的，然后你再开始去想我要给孩子准备一个什么样的“养育拼盘”。

我们一直讲养育大于干预，所以你一定要先停下来回归到最初，想想这个问题是怎样影响到我们的孩子的，然后给孩子打造一个完整的“养育拼盘”。这个拼盘包含针对孩子不同方面的干预方法、不同的疗法等。

我们家长一定不要轻易受到其他人言论的干扰。就拿孩子说话晚这件事来说，如果你的孩子的语言水平明显低于同龄孩子，即使不是孤独症，你也要尽早排查是否有什么其他问题影响了孩子的语言能力的发展。真的不要被什么所谓的“贵人语迟”这种话给耽误了。如果孩子有问题，年龄越小干预效果越好。另外，我们的大脑终身可塑，所以只要进行干预，什么时候开始都不算晚。重要的是迈出关键的第一步。

孤独症的诊断标准

目前孤独症的诊断标准用的是 APA 推出的 DSM-5。既然是“5”，那么前面肯定有“1、2、3、4”吧？是的，后文我会进行介绍。

可以说 DSM-5 诊断标准的推出对于我们的孩子影响很大。它里面包含两大类指标：第一大类我们叫 A 大类，涉及重复刻板行为、与感官相关的行为；第二大类我们叫 B 大类，涉及沟通和互动障碍。目前孤独症的诊断标准是：A 大类符合2项，B 大类符合3项，基本上可以确认是孤独症了。那么，我们如何知道孩子是不是符合这个 A 大类2项、B 大类3项呢？这就是我后面要讲的诊断过程。

在 DSM-5 诊断标准里，有一个非常新的概念——社交沟通障碍（Social Communication Disorder, SCD）。意思是什么呢？如果你的孩子符合 B 大类里面的很多指标（主要体现在社交互动能力落后），但是没有 A 大类的指标（没有重复刻板、感官相关的行为表现），那就不诊断为孤独症，而要考虑 SCD 这个诊断。

在早期的DSM-4诊断标准下，要有三大类的指标才能被诊断为孤独症，即除了重复刻板行为、社交障碍以外，还要有语言发育迟缓。孩子必须符合这三大类指标中至少半数以上的指标，才符合孤独症的诊断（当时称为典型孤独症）。如果不符合，但你的孩子仍然有一些问题，比如符合两大类或一大类，则被归为广泛性发育障碍（Pervasive Developmental Disorder, PDD）的诊断。如今DSM-5已经取消了PDD的诊断，将其归入了孤独症谱系障碍的诊断范畴。

所以看到这里大家就明白了，为什么在过去的这几年感觉孤独症孩子越来越多，其中有一部分也是因为诊断标准发生了改变。

诊断过程是什么样的？

了解了孤独症的诊断标准，那你可能会问如何判定孩子是否符合诊断标准呢？我们来说一说诊断过程是怎样的。孤独症的诊断过程分成两类：第一类是填量表，第二类是孩子与医生互动。但是说实话，孩子与医生互动还是回归到一个填量表的过程，只不过这个量表和前一个量表不同罢了。

第一类表格是筛查类量表，即先看看你的孩子与典型发育的孩子是不是有差别。这个量表多半是由孩子的家长或者老师自评填写，最典型的比如孤独症儿童行为评定量表（ABC量表）、CABS 克氏量表、幼儿孤独症筛查量表（CHAT）等，总之就是家长（或老师）自查表。仅靠这样的表格不能进行诊断，但可以提供一个评分。

第二类表格是诊断类量表，由医生根据与孩子的互动情况进行填写。国内目前通用的有两种：一种叫孤独症诊断观察量表第二版（ADOS-2），另一种叫儿童孤独症评定量表（CARS）。

然后医生将这两类表的结果结合在一起，做出孩子“是否符合孤独症诊断标准”的判断。

其实不难看出，这个诊断过程有两个特点：一是比较主观，不管是家长（或老师）填的表，还是医生填的表，都是根据主观判断下的结论；二是医生与孩子互动时间相对国外来说很短，门诊医生可能最多也只能跟孩子互动30分钟，绝大多数是5~10分钟，但在北美国家基本要求医生跟孩子互动时长至少要达到几个小时甚至一天，才能够给出一个完整的观察量表。这样就可能造成我们家长在孩子确诊的时候，无法从医生那里获得关于孩子情况的完整解读，所以需要我们自己多了解、多学习、多观察。

诊断不能单纯靠经验

可能有的家长会说，医生那么有经验，肯定观察得八九不离十啊。其实不是这样的。道理很简单，不管你的孩子是否有孤独症，你都可能经历过孩子到一个完全陌生的场所或面对一个完全陌生的人时表现得和在家里不一样，尤其到医院这种不是很令人愉悦的环境；或者孩子没睡好觉；或者前一天遇到了什么不愉快的事情……这些都可能影响孩子的状态，干扰医生的判断。我还记得我的小儿儿子小时候第一次见医生的情景。当时因为他前一天刚刚打过疫苗，导致第二天一见到穿白大褂的人他就大哭。

孤独症的诊断是一个非常严肃的事情，它代表着宣告孩子将是终身残障。所以，我们不能仅通过几分钟的观察和经验就做出完整、准确的诊断。

在北美，医生们至少要跟孩子待一整天，且需要不同领域的专业人士参与，比如言语治疗师、作业治疗师、家庭医生。同时，医生必须是经过有关ADOS-2方面的专业培训，才知道如何正确填写诊断表格。目前国内接受过这方面培训的医生主要集中在孤独症相关的专业领域，家长在就诊时也要注意这一点。

当然，这就带来了一些问题，很多家长拿着找来的 ADOS 的评分去对比新的ADOS-2给出的结论，或者用CARS来看 ADOS，这是不行的，两套体系的评分标准是完全不一样的。所以，家长要明白，当你们带着孩子去做诊断的时候，一定要问清楚医生用的是什么量表，这个量表的分数如何解读，这些问题家长一定要问清楚！

诊断的意义是什么？

孤独症诊断的意义到底是什么呢？意义就在于它决定了你的孩子未来干预的起点！所以我一直强调，诊断是一件非常严肃的事情。

① ADOS-2是ADOS 的修订版，其中包括修订了算法和模块1至模块3的分数比较、更清晰管理和分数对应指引，以及专为12~30个月的语言能力低的儿童设计的新幼儿模块。

曾经有一位家长眼我说了这样一件事：夫妻俩带着孩子到某机构，机构工作人员认为孩子是孤独症。随后他们又带孩子去了医院，然而医院的医生说没有办法确诊，应该找之前的机构确诊。听到这件事情让我很震惊！

首先，前面我提到的，孤独症的诊断标准是 APA颁布的。所以，有资格给孩子做出诊断的首先应该是儿童精神科医生（而不是机构老师！）。我国的儿童精神科医生并不算多，据统计还不足 500 人。如果实在找不到合适的儿童精神科医生，就去找儿童心理科医生和儿童发展科医生。除了这几个专业的医生之外，其他科医生是不具备诊断水平的。我碰见过这种情况，一位其他科的医生直接拿个 ABC量表让家长填写，填完了之后他看了一眼，然后跟孩子玩两下就确诊孩子孤独症了。

其次，孤独症的诊断不是单下一个是否是孤独症的结论即可。这还不够！

DSM-5 的诊断标准里给孤独症儿童做了一个轻中重度的划分，依据是什么呢？是以孩子所需要支持力度来划分的。

所以说，孤独症诊断的意义在于决定了孩子未来干预康复的起点！各位家长，你要知道孤独症是如何影响你的孩子的；要知道你的孩子是哪些方面的能力有缺失；孤独症是如何影响到孩子的语言能力、认知、社会性能力以及生理等方面的。我们如何着手开始给孩子干预，与准确的诊断分不开。

何谓高功能、低功能？

我们一直在强调孤独症儿童所谓的问题行为，很多时候是与环境互动的结果。所以，孤独症的诊断标准中关于症状的描述，归根结底是孩子当前的能力和当前所处的环境的需求不匹配所呈现出来的状况。DSM-5把孤独症按照轻中重度来划分，是不以症状的严重程度而是以所需要的支持力度来划分的。这是与之前非常大的区别。所以，当你看到孩子有问题行为时，不要觉得是你的孩子有问题，而要是他的能力与所处的环境如何不匹配。

孤独症儿童走上的是一条不一样的发展道路，我们最终能够帮助他们的其实就是去修复这条发展道路，尽可能地修复。不管是高功能还是低功能，修复之路的目标都是一样的，即一定是往典型发育的道路上去修复，因为这样才能够真正帮助孩子适应这个由典型发育的人主导的社会。

一旦孩子确诊了孤独症，就请尽早开始干预吧，不要犹豫！但是我要跟大家说的是你给孩子安排的干预一定不能踩的坑。首先，不能违背儿童发展规律！孩子不是小一号的大人，你不能参照大人的执行能力、社会性能力来要求孩子。

孩子两岁多不听话，这是正常的，因为此时他正处在自我意识发展期。你要求一个在自我意识发展期的孩子无原则地、无条件地听指令，就是在违背儿童发展规律！这种类型的干预千万不要做！

其次，不能以牺牲孩子的心理健康、情绪稳定为代价。如果你的孩子一听到“老师”“上课”“教室”这样的字眼就崩溃，情况已经这么明显了，你还是带着孩子到机构进行每天8小时的干预，那我我觉得你也甭干预了！你首先要做的最重要的事情是学习儿童发展相关的知识，包括认知发展和心理、心智是如何发展的。我们进行的所有干预都是希望孩子未来在社会上能够好好生存下去。你应该是自己首先更加了解这个世界的运作规则，并教给孩子，而不是把孩子修炼成一个机器！

有的家长朋友还可能有这种心态——最省事的方法就是把孩子交给老师或者交给机构，其实这是很大的一个坑！我们都说要走出来，但真正我们的家长走出来的那一天，不是孩子脱帽的那一天，而是你觉得无论要走多远，你都有能力给孩子足够的支持的那一天。

好，那我们说一说高功能和低功能到底是什么意思？前面说过，DSM-5 诊断标准里，将孩子孤独症的严重程度按照需要的支持力度和广度进行了划分，表现在难以发起社交互动，可能会对他人做出的社交：1级是指“需要支持”社交邀请表现出不寻常或不成功的反应，而且对社交互动的兴趣降低。此外，重复的行为会干扰日常功能，以及伴随一定的兴趣狭窄。2级是指“需要实质性支持”，表现在言语和非言语交流方面的明显延迟。发起社交互动的兴趣或能力有限，即使有支持的情况也很难与他人建立社交关系。非常明显的重复性行为以及兴趣狭窄，并且当兴趣和（或）行为被中断时，可能会出现高度的痛苦或沮丧。最严重的就是3级“需要非常实质性的支持”，表现在日常功能严重受损，发起社交互动的能力非常有限，对他人的社交邀请无视或回避，言语交流能力极其有限。固定的仪式和（或）重复的行为极大地干扰了日常功能。像我的两个孩子，就是最严重的这一级。

那么问题来了，这里面没有提到高功能/低功能啊？

没错，因为本来就没有一个诊断结果叫作“高功能孤独症”或者“低功能孤独症”。目前对于这种说法，大家的观点是，一方面可能是历史原因，在前一版的诊断标准DSM-4里面，有所谓的“典型性孤独症”和“广泛性发育障碍”的区别，基本上就是符合我们现在说的低功能和高功能的特点。另外一个原因是我们可能对于孤独症孩子有一个大概的印象上的划分，好像那些会说话的孩子被视为高功能，无语言的孩子则被视为低功能。

总的来说，我基本同意这些观点，也做了我自己的解读，给大家参考。智力发展、语言发展和基本日常生活的能力没有明显受损，并且没有显著共患病影响的孩子，可以视为“高功能”或者“功能较好”。而那些智力受损、语言明显落后以及日常生活的能力受限，且伴随共患病的孩子，可以视为功能较低。同时，在康复效果和预后期望上，两者也会有一定区别。比如，高功能（或阿斯伯格综合征）的孩子，能够“泯然众人”的机会，应该会比低功能的孩子更大。所以目前在国外的孤独症社群里，也有越来越多的声音在呼吁，对于功能不同的孩子，尽管都顶着孤独症谱系这样相同的大帽子，但是在康复目标和措施上，还是要做出区分。

那么说到这里，对于低功能和高功能的孩子，有什么需要注意的不一样的地方呢？

低功能的孩子，往往一看就有问题，所以家长经常容易犯的错是——过度补偿。家长觉得孩子这也不行那也不行，所以什么事情都替孩子干了！有很多低功能的孩子上幼儿园时，会有家长或者影子老师陪读，我们就要特别注意他们可能会对孩子过度补偿。而这种过度补偿，也只是表面上的支持，家长或影子老师并没有意识到低功能的孩子能够自主地做很多事情，也不会有意识地给他们机会尝试，结果就是这些孩子的潜力和发展机会被压制了。

高功能的孩子有个很典型的特点是——独自待着时表现都很好，但当处在人群中时就会出问题（例如，会有挫败感、突然情绪爆发或者崩溃等）。这样的孩子遇到的问题是，他们得到的支持和所需要的支持不匹配。正是因为他们“看起来”挺好，也造成大家会忽略他们是特殊需求的孩子的现实，导致他们明明需要支持的地方没有得到支持。

我碰到过一个极端的例子：一个孩子长期处在与人互动受阻和压抑的情况下，突然有一天他冲进家里的厨房拿了一把刀就冲到马路上了！这就是孩子集中的爆发。2019年，我到深圳开讲座的时候，当时就有一个高功能孤独症孩子的妈妈分享了她孩子的事情。她的孩子各方面能力都不错，但在学校有一天突然站起来拿着椅子到处砸。

当高功能的孩子遭遇各种挫折的时候，他会紧紧抓住给他带来安全感的東西，比如刻板行为、有规律性的事物，或者固定不变的程序，然后他会变得越来越刻板。另外，高功能的孩子也容易以自我为中心，当大家在一起交谈时，他只喜欢谈论自己喜欢的话题，而不在意别人在说什么。

所以，总体来说，低功能的孩子，注意避免过度补偿，尽可能地鼓励孩子发挥自主性。而高功能的孩子，避免想当然地觉得他们可以，而忽视了他们的需求。

干预过程中家长不应有的心态

我认为对我们家长来说，首先就是要走出危机心态，要对孩子有一个长远的愿景。

我在给 RDI 顾问学员讲课的时候，经常会说的一句话，是要求我们的学员在面对家长的时候，要默认家长们都是有“创伤应激”的。

养育一个（或者两个）孤独症孩子，这对我们来说，何尝不是一场“重大灾难和创伤”呢？

然而重要的是，我们要努力开始“灾后重建”，用积极的心态去面对。你可能会问，高功能孩子的家长是不是会好一些？其实不是的，他们也有很多的无奈和痛苦。为什么？因为高功能的孩子往往表面看起来很正常，当他们出现问题行为时，外人就会很不理解，认为是孩子家教不好。比如，孩子的语言能力不错，又有强烈的社交动机，那么周围人对他的容忍度和宽容度就会很低，一旦出现问题，孩子得不到周围人的理解、他的需求与得到的支持完全不匹配，就会让家长很痛苦。

所以，我们要正视和接受这件事，家长首先自己要明白孩子真正需要的是什么。随着孩子的成长，会遇到很多的挑战，社会对他的要求也会越来越高。只要孩子有一点进步，那就是一个很大的里程碑。在 RDI 干预体系中，我们的第一个目标，就是帮助家长走出危机心态，为孩子树立一个长远的愿景。

我们有一个家长，孩子是 2 岁确诊的孤独症，但在 5 岁前没有进行过有效干预，孩子有很多的问题，先后被 6 家幼儿园劝退过。孩子 5 岁开始有了一些零星的主动性语言，真正开始有较多的主动性语言是 7 岁时，现在孩子 10 岁，他的沟通能力基本上已经算比较正常了，但是确实在语言的复杂性和流畅性上还有一些问题。这个孩子读小学一年级时，妈妈一直在学校里陪读；二年级时有一半时间陪读；三年级开始逐渐撤出，但是每周可能去两次；四年级完全撤出。所以，对于孩子干预效果的预期，我们的时间长度可能要拉得长一点，愿景上要放得远一点，千万不要因为急功近利而让自己和孩子陷入无谓的焦虑。

我想提醒大家不应有的另一个心态是——认为最省事的方法就是把孩子交给老师或者交给机构（我在前面也提到过）。这真的是很错误的想法！

当然，我的孩子也曾经在机构中接受干预，也取得了一定的效果。我一开始也有这种心态，反正我交给机构就好了，我就可以在旁边休息了。但是可能吗？待孩子长大到七八岁时，我们很多家长就发现只靠机构的干预真的是不够的！首先，很多机构都是针对低龄儿童的，孩子大了你就没有那么多机构可以去了；其次，孩子的核心问题在机构里面并不能得到完全解决，必须延续到生活中去应用；最后，孩子年龄的增长也会带来不同阶段的挑战和问题，这时候只有父母在日常生活中的引导，尤其是互动方式，才会最直接地影响到孩子。

就像每个家长一样，我也经历过崩溃和到处看人不顺眼、恨不得大家的日子都别过了的冲动日子，但是后来我的心态越来越稳定，直到今天，真的是得益于 RDI，因为即使孩子出现新的问题，我心里也是有底、能给他正确支持的。RDI 是一个系统的干预体系，它推动着家长和孩子一步步向前走，帮家长做到的是——生活即干预，这才是王道！

我记得有位学习过RDI的家长说过，最厉害的干预是什么？就是能在生活中潜移默化的干预方法。

第二章

我的孩子是孤独症，到哪儿治？

孤独症对每个孩子的影响都是不一样的，学习如何为孩子选择合适的干预方法，你一定要先明白：孤独症是如何影响孩子的？孩子当下各方面的能力如何，有什么表现？孩子能力的受损程度如何？……这是我们选择干预方法（或疗法）的出发点，正所谓“授人以鱼，不如授人以渔”。

下面这张表格，总结了目前孤独症的主要干预方法。

孤独症主流干预方法的关键信息

干预方法	核心理念	特点	国内发展状况
ABA	行为塑造	ABC、DTT	鱼龙混杂
PRT	ABA 的延展	内在强化、生活场景	资源较少
NDBI	结合发育科学的 ABA	强调自然发生的场景	发展中
RDI	互动环境对发展的再塑造	生活化干预、家长赋能、动态智能	发展中
PCI	通过互动环境提升儿童对人的关注	游戏、文化介入	发展中
DIR	根据儿童兴趣创造互动机会，发展社交能力	地板时光，强调沟通回合作为互动基础	资源较少
ESDM	全方位定制支持	团队性、定制性	几乎没有（正宗的）
SLP、OT、PT	高度专业的功能修复	高度专业、定向	数量极少
生物疗法	功能医学改善症状	高度专业、费用高	鱼龙混杂
感统训练	改善感知觉体系	门槛低、应用广	万金油、鱼龙混杂

两大流派

第一大类：行为流派

孤独症的诊断标准是基于孩子呈现出来的行为表现。根据这个思路，我们是不是可以这样理解：只要让孩子的问题行为没有了，孤独症是不是就好了？很多行为疗法就是以这样的思维模式发

展出来的。

行为疗法的典型代表是应用行为分析（Applied Behavior Analysis, ABA）。关键反应训练（Pivotal Response Treatment, PRT）是把传统 ABA 里面的外在强化转移成一种内在强化的方法。

另外还有言语行为法（Verbal Behavior, VB），它其实不是一种行为疗法，是一种依据 ABA 和语言行为所发展的教学方法，认为语言也是一种可以被塑造的行为方式。

第二大类：发展流派

发展是什么？发展是皮，技能是毛。我们为什么这么说？3岁孩子所呈现出来的换位思考技能和9岁孩子所需要呈现出来的换位思考技能一定是不一样的！我们不应该脱离孩子的发展阶段去谈技能表现和行为表现。3岁的孩子蹦蹦跳跳是完全合理甚至被鼓励的，但是30岁的人总是蹦蹦跳跳就不合理了，对不对？所以技能也好，行为表现也好，一定是镶嵌在发展当中的。20世纪80年代有一大批人开始研究儿童发展在孤独症的康复中的重要作用，发展流派应运而生。他们认为脱离了发展的基础和底层去谈技能和某些具体的行为其实是无本之木。

在发展疗法中，先提一个疗法——DIR（Developmental Individual-Difference, Relationship-Based Model），翻译成中文是基于关系的个性化的发展性疗法，又称地板时光（Floor Time）。什么叫地板时光呢？因为它的创始人斯坦利·格林斯潘博士认为：所有的儿童成长是从地板开始的。所以，DIR 疗法的最初状态，也是跟随孩子的游戏愿望在地板上完成的。

ESDM 的‘坑’

ESDM（Early Start Denver Model），即早期干预丹佛模式，它是一个把发展流派和行为流派整合在一起的方式，所以千万不要说ESDM 是行为流派。在ESDM 的官网上是这么介绍的：是发展性的、基于游戏的、基于关系的底层逻辑和应用行为的处理原则相结合的方法。什么意思呢？就是我相信关系对于孩子的干预的重要性，在具体技能上采取借鉴了 ABA 行为疗法的方式和方法，所以ESDM它是集合了发展流派和行为流派的方法。它强调早期干预，针对的是4岁以下的孩子。

我为什么说它最“坑”？非常简单，我听过很多家长说 ESDM 这个方法很好，模块标准和操作写得很清楚，家长在家就能做。我当时就心想，ESDM 的创始人看到真要吐血了。ESDM 最重要的核心是什么？是专家团队！它的方法写得非常清楚，ESDM 的所有目标是需要多学科专家来完成的，比如心理学家、言语治疗师、作业治疗师、特教老师等。但目前国内像言语治疗师、作业治疗师这样的专业人士还很少。

可以说，ESDM 是在国内落地最差的一个干预方法，虽然它本身相当好，但是国内有认证资格使用这一干预方法的人却比较少，可能因为它在国内属于比较新的方法，而且它要求的是一个基于整个社会的干预体系基础去完成的。当然，如果我们的家长能够构建一个比较专业的支持团队，或者说我们通过ESDM 来了解孩子的早期发展模块及它们之间的关系，那么 ESDM 是很值得推荐的早期干预方法。

何谓功能性疗法？

在孤独症领域，还有第三大类疗法——功能性疗法。

所谓功能性疗法，就是针对某一个具体功能的疗法，常用的方法有以下几种。

针对孩子语言发展，需要的是 SLP（Speech-Language Pathologist，言语语言病理学家）。大家可能也听过 ST（Speech Therapist，言语治疗师），但是我个人更喜欢 SLP 的说法，为什么呢？SLP 是把言语和语言分开来了。我曾经讲过一堂课叫《言语和语言发展》，名字听起来挺绕，但实际上大家一定要明白言语和语言是两件事。言语是嘴巴里发出来的，语言则是沟通交流的手段，所以语言涉及人的思维、归因、对于环境的应激表达等。我们的孤独症孩子，很多时候他们的口语或者言语是可以的，但是沟通能力却很差，比如与人聊天的时候只说自己想说的，或者可以大段背诵动画片台词，却很难表述自己的内在感受。所以我觉得，对我们的孩子来说，语言比言语更重要。

OT（Occupational Therapy，作业治疗）是做什么的呢？简单地说，OT 是教孩子吃喝拉撒睡方面的能力，且教的是家长，让家长明白如何在生活中运用各种技巧帮助孩子发展这些能力。从事 OT 行业的专业人士被称为作业治疗师。

PT，即 Physical Therapist，物理治疗师。如果你的孩子有运动功能障碍，那就需要 PT 的帮助。孩子要能够完成吃喝拉撒睡需要有一定的运动功能，所以 PT 与 OT 是有交叉的，但 PT 更多偏重提升运动能力、运动计划能力。比方说有的小朋友肢体不协调或者很难完成跨中线的动作（即左手拍右脚、右手拍左脚这样的动作），那么他其实是需要 PT 帮助的。

CBT，即认知行为疗法（Cognitive-Behavioral Therapy）。有研究发现，孤独症儿童有 70% 以上伴随情绪问题，焦虑和抑郁发生概率非常高。CBT 可以帮助缓解孩子情绪问题和心理障碍。

最后，我还要说说感统训练。有的人可能会把感统跟 OT 画等号，这是错误的。感统训练和 OT 绝对不一样！OT 可以涵盖感统训练。如果孩子的感统有问题，出现肢体不协调或者他的日常生活相关的身体功能（比如吃喝拉撒睡）直接受到影响，那么就要依靠 OT 来解决。作业治疗师会判断孩子的生活能力受损是感统的问题还是其他的问题，从而给予针对性的治疗，所以 OT 的范畴是大于感统训练的。另外，在专业领域，这些年感统失调这个词已经不太用了，而是被另外的词——SPD（Sensory Processing Disorder，感觉处理障碍）涵盖了。

国内的‘鱼龙混杂’

关于孤独症的康复领域，国内发展状况是“鱼龙混杂、并不完善”。

我们是在否定这些干预疗法吗？当然不是！我们相信这些干预疗法都有其独特的针对性、适用范围、特点。但什么说是“不完善、鱼龙混杂”呢？我觉得主要是康复治疗专业在国内起步是比较晚的，没有发达国家完善，这里面涉及医疗体系和教育体系。孤独症的研究已有一百二十多年的历史，近些年由于多学科之间的互相支持和互相印证，推动着孤独症康复领域的高速发展。然而国内

就相关疗法引进的书籍或者知识体系，很多都是国外三四十年的内容，并没有做到紧跟研究前沿、与时俱进。

另外，就是缺乏专业的从业人员。我可以很负责任地跟大家说，我碰见非常多所谓的ABA的一线老师，我问他们什么叫 ABA，第一个A指的是什么，B指的是什么，第二个A又是什么？他们很多都解释不出来。我国人口基数大，特殊儿童数量庞大，如果专业人员的培训跟不上，就会出现很大的供需缺口。有一些机构只想让家长看到“见效快”，所以催生了很多“速成品”。然而，教育本身就不是速成的，尤其是特殊儿童的教育。

由于缺乏足够的专业人员，所以很多时候经常是靠家长往前不停推进，去看这个世界上孤独症前沿发展到底到了哪一步。以我自己为例，我会利用每天早上6点到7点的锻炼时间，收听孤独症研究领域最前沿的报道。有一天早晨，我听到一个关于加州大学戴维斯分校关于孤独症儿童执行功能的研究报告。大家可能普遍觉得孤独症孩子的执行功能不好，但这个研究报告称他们并不是不好，只是不同。

我们要知道，任何事物的发展都是有一个过程的。我相信未来国家一定会越来越重视这件事情，给到越来越多的支持。那么在当下，我们作为家长就需要辛苦一点，自己先深入了解各种干预方法，了解它们具体解决孩子的什么障碍和问题、有什么特点、国内的发展现状是什么。这样，在选择机构时，你就会对它们的从业人员的专业性和干预体系的科学性有一个客观和准确的判断。

ABA 的背后，我们要懂的.....

我想强调的第一点是“ABA”中的第二个“A”，为什么？因为我发现有很多所谓的ABA 机构所犯的错误一没有前期对孩子的行为进行分析，就直接拿出 40张卡片开始教孩子，这是违背了 ABA 的原则。ABA 要求干预师在给一个孩子做干预之前，要进行非常多的分析工作，大概需要两到三周的时间，并且结合观察分析填写专业的表格。干预师要分析孩子的行为在什么样的环境、场景下发生，导火索是什么，行为发生后他的互动对象如何应对，这个应对方式给孩子造成的是正强化还是负强化。如果不进行观察分析就直接上手给孩子做干预，你认为这是真的ABA吗？

在ABA 中，会用到 ABC行为分析的方法。A代表 Antecedent，即行为前因；B代表Behavior，即行为；C代表 Consequence，即行为后果。其中“C”是我想强调的第二点。我们通过呈现不同的后果来帮助孩子调整自己的行为，这是ABA 的底层逻辑，但这也是大家非常容易“踩坑”的地方。我看见非常多的这个行业的从业者是怎么干的呢？他们把重点放在孩子的行为好就奖励孩子，孩子的行为不好就惩罚孩子。这绝对是错误的，这样造成的结果很可能是孩子被动的服从，这不是干预的目标！正确的做法是运用“后果”这一工具，帮助孩子理解自己以及学会调整自己的行为。ABC 行为分析的方法并不是只能在ABA 中使用，我认为即使在 RDI的干预体系中也有它的用武之地，重要的是如何正确地去使用。

我觉得ABA 比较大的一个问题是原则特别难把控。绝大多数机构的一线老师，对于孩子本身的特性和发展规律并没有足够的研究，这些操作人员只是生搬硬套，不是去思考如何更好地使用自然

结果、逻辑后果，去帮助孩子思考学习和自我纠正，而是单纯以惩罚为目的去给一个造成厌恶反应的后果。所以我觉得这是 ABA 值得大家好好思考的一个地方。

何谓 PRT?

PRT是ABA 的延展。因为研究人员发现传统ABA 里面有很多容易“踩坑”的地方，不是 ABA 不好，是操作者在执行过程当中容易走偏。一旦我们在执行过程中对孩子的管理者心态出来了，就容易走偏。而PRT 就是针对这些容易走偏的地方，对传统 ABA 做了一些调整和延展。

与传统 ABA 相比，PRT强调的是对孩子的内在强化。它把孩子自己的意愿、兴趣、成就感和乐趣作为了内在强化。举个典型例子，你跟孩子在一起玩，孩子玩得特别开心，这时候你突然停下来不动，创造了一个引发沟通的机会。如果你这时候的目标是想让孩子多运用语言、多提要求，那么你就示范给孩子看，比如你说：“跟我一起玩吧。”如果孩子也这么说了，你就立刻跟他一起玩，这个时候重新开始玩就变成了对孩子的内在强化。

PRT 在中国的实施情况并不完善，虽然大家看过很多关于 PRT的书，但是真正在过程中去执行 PRT 的机构和老师并不多。这一点我也觉得有一些可惜。我是一个从PRT学起的人，的确受益良多。然后我进入到发展流派去学习RDI，我又发现了发展流派的优势所在。

以RDI来说，它的特点是什么？RDI 更多的是一个学科的合作，它有非常多脑科学的内容为基础。我提到过，孩子任何技能的发展都必须遵循儿童发展的规律，RDI 的理论体系就是对标的典型发育儿童的发展状况。而当我们来观察典型发育儿童的发展路径，我们就会发现，作为父母最有力的工具和武器是什么呢？就是我们能够给予孩子的互动环境，对于孩子的大脑发展的偏差路径进行修复，也就是说我们可以通过为孩子打造适合的互动环境对孩子的大脑发育进行再塑造，这就是 RDI 的底层逻辑——它强调的是生活化的干预，强调给家长赋能。RDI 致力于发展孩子的动态智力，它需要家长一直给予孩子长期的辅助，直到孩子达到一个生活独立的状态。就好像说，RDI 画下了正确的方向和路径，这时候我们的干预就会有的放矢，不会走偏，当然也更加高效。

何谓生物疗法？

生物疗法的发展时间已经非常长了，我们最早了解这个概念，应该是在20世纪80年代，伯纳德·里姆兰德（Bernard Rimland）博士提出的，用维生素B。₆+镁缓解孤独症症状。

关于生物疗法到底是好还是不好，是否有用，我专门咨询过加拿大最顶尖的儿童医院多伦多儿童医院自闭症研究中心的主任，他给我的答案是，这个研究方向是非常好的，它研究的不是给孤独症儿童吃什么药，而是研究孤独症儿童的生物学指标和功能医学的关联。孤独症是发展性障碍，问题出在孩子的大脑，但是问题可不可能出在身体的某些生物因素上？身体的这些问题如果解决了，能不能去辅助大脑的修复？……这是生物疗法的研究方向。但到底结论如何，目前还都是未知数！

有很多报告表明胃肠道问题可能引发孤独症症状，澳大利亚一家研究机构的最新研究报告表明，孤独症儿童的胃肠道问题不是引起孤独症症状的原因，而是孤独症引起了胃肠道问题。所以，正如我前面讲过的，这个领域，还有很多未知数。

我个人的建议是什么呢？一切以孩子的健康为标准。如果你觉得给孩子吃点益生菌、有机食品等健康食物，以及多观察孩子的过敏症状，是对孩子健康有利的，那就没有问题，但千万不要随便尝试一些疗法。曾经有家长问我粪菌移植效果怎么样，我会劝大家谨慎，因为粪菌移植的危险性还是很高的。大家可以看下美国 FDA 在 2019 年发布的一个信息，就是关于粪菌移植的安全性的。当然，现在各个国家也都在进行持续的尝试，包括国内的很多医院。所以，我个人建议对于生物疗法要持续关注、大胆假设、谨慎尝试。

感统 & ALP

感统训练在国内是这样的场景：老师会把孩子带到一个教室里，教室里面有秋千、陀螺、滑梯、障碍物、豆袋、垫子等设施，然后老师带着孩子做各种各样的运动，说在给孩子上感统课，其实变成了运动课。大家一定要把运动和感统训练分开。运动能够帮助我们的孤独症孩子，这是毋庸置疑的！你让孩子去运动，一点儿问题都没有，我非常支持，但是运动并不等同于感统训练！大家去上感统课时，不妨问一下孩子的感统老师，他知不知道什么叫 SPD？能不能解释一下什么叫感统？如果他能够清楚地告诉你孩子具体是哪方面的感觉处理障碍，针对孩子的问题有哪些方法以及为什么给孩子设计这样的感统训练，这样的老师才是具备足够的知识来帮助孩子的。

有的家长可能听说过一种所谓的杏仁核靶向治疗。什么叫杏仁核靶向治疗？杏仁核是什么？杏仁核和海马体包括我们的脊髓连在一起叫边缘系统，边缘系统在孤独症孩子的发展当中是有非常大的作用，对孤独症孩子执行功能也是有很大的作用。孤独症孩子边缘系统受损的情况、如何受损，这些根本就没有标准没有结论的时候，就来个靶向治疗，你当癌症去治啊？大家千万不要相信这种疗法！

有很多朋友会问 ALP（Active Learning Program，主动式学习方案）和 RDI 的区别。ALP 跟 RDI 没什么关系，它是由 RDI 的实习顾问借鉴了 RDI 的方式和方法，自己发展出了 ALP 体系，但后续 RDI 的动态智力发展部分并没有融入其中。不过今天 RDI 能够进入到中国家庭，ALP 是做了很大贡献的，在这里就不赘述了。

如何判断机构好坏？

回到很现实的问题，家长该如何冷静理智地为孩子选择干预机构呢？如何判断一个机构是不是专业的？如何结合机构的建议，为孩子选择恰当的干预课程？

我觉得首先很重要的是，我们家长自己要有一定的知识积累。投资自己是最重要的，因为你是一直陪伴孩子成长、解决孩子成长过程中各种问题的那个人。绝大多数干预机构对孩子提供支持只

是到6岁，难道我们的孩子6岁后就不需要支持了吗？不是的！他们越长大反而需要的支持越多。而谁能在他们的成长过程中不断地给予辅助和支持呢？那就是家长！所以，家长一定要学会先投资自己！我每年在自我学习上花的钱非常多。

其次，你要注意，如果你跟机构的老师交谈时，他告诉你这是帮助你孩子的唯一的方法，请不要相信，因为这个世界上根本就不存在能解决孤独症孩子问题的唯一方法！

关于发展流派的疗法，我还想提醒大家的是：没有经过几十年以上发展历史的发展疗法，不要轻易尝试。原因很简单，研究发展是需要时间和数据积累的。我们的精力有限，请把你的大部分精力都用在研究主流的干预方法上，这样你就有基本的能力去判断一个机构或者一个老师好不好。

讲了这么多的干预方法，我想说的是这些方法本身没有错，我们不是一棒子把这些方法都打趴下了，同时也不是一味否定国内的机构。我们更需要你真的自己去了解，去学习，至少是知道一些关键信息，然后你才可以做出正确的选择和判断。国内的干预机构也并非都很糟糕，还是有很大一批机构是很正规、勤勤恳恳地为孤独症群体服务的！

这三座大山你不翻过去就不要谈脱帽

孤独症是一种发展性障碍，随着孩子年龄的增长，可能会出现更多的问题。在我看来，在孩子未来的道路上，有三座大山需要翻越：第一座大山是应对青春期出现的各种问题；第二座大山是能够独立自主，维持良好的社会关系，能与他人保持沟通；第三座大山是进入并维持亲密关系。孤独症人士要想脱帽，这三座大山就一定要翻过去。我曾经看到一个最新统计数据，显示美国获得大学学历的高功能孤独症人士中只有5%能够真正独立自主地生活。可见，要想脱帽并不容易。

为什么随着孩子年龄的增长，问题反而越来越多了呢？这可能和青春期激素水平的变化有关。我碰到过很多孩子在青春期出现大倒退的现象。有一位妈妈跟我聊过她儿子的事情，她儿子当时正处于青春期，有一天突然在学校公开场所脱裤子，而他却不自知。还有一个孩子，读初中的时候还是班里的数学尖子，但到了18岁的时候只能待在家里，语言能力完全倒退。还有的孩子会在青春期出现很严重的情绪问题，尤其是当别人对他们提出反对意见或者指出他们的问题时，他们就会情绪大爆发。但是，我确实也碰到过一些在青春期各方面表现都不错的孩子，这部分孩子之所以有这样的进步一定是前期干预积累的结果。

所以，家长一定不能从是否完成学业这个标准，判断孩子是否脱帽了。孩子能上学，智商不错，绝不代表就可以脱帽了。

作为家长，希望孩子能脱帽、像正常孩子一样，那么正常孩子是什么样的你知道吗？希望孩子走上一条典型发育的道路，那么典型的发育道路是什么样的你知道吗？有些家长会觉得孩子不听话，一定要把他的不良行为消除掉，可是如果这个行为是他发育过程中本来就会出现的呢？比如孩子在规则敏感期会很执拗，在自我意识萌发的时候会不管不顾地凡事要求自己，很多时候都会做出让家长很抓狂的“问题行为”，那这时候要去压制孩子吗？

如果这些问题引起了你的思考，那么请你一定要去学习一下儿童发展规律相关的知识，我们才能清楚地看到前进和努力的方向。

为什么要选 RDI?

我为什么会推崇 RDI? ABA、PRT 我都学了很多，不是说没有用，而是走到一个阶段，我突然发现我走不下去了，为什么呢？因为我发现我进入了一个非常糟糕的境地——孩子生活的方方面面都必须我手把手地来教，然而这个世界如此纷繁杂乱，孩子成长光靠我来教是教不完的。

举个简单的例子给大家。比如，我跟儿子逛商场时上厕所的问题，孩子要进男厕所，而我要进女厕所。当孩子进到厕所的那个瞬间我脑子里其实在想一件事情，就是我教会了他上厕所的所有步骤，他所有的步骤可以很精准地去完成，但是这绝对不等于我可以放心地让他自己进入厕所，这里面有太多的不确定性和未知性，是我没有办法一一去解决的，我也教不会。再有，我们和孩子在一起的感觉和情感联结，可以用量表来衡量吗？不可以。孩子的自我意识成长有量表参照吗？没有。孩子的内在动力有量表参照吗？也没有。

还有一种情况是，当孩子遇到一些困境不知道该怎么办的时候，他们会看向爸爸妈妈，看爸爸妈妈是怎么做的（社会性参照）。问题是，这个世界上有太多问题没有一个对错的答案，我没有办法告诉孩子哪些行为是对的、哪些行为是错的。举个简单的例子，我问孩子你今天开心吗？这问题有固定答案吗？答案有对错吗？没有。所以我进入了一个我走不下去的状态，然后我找答案的时候，就接触到了 RDI。

在把 RDI 用到我的孩子身上一段时间之后，发生了一件事情让我确信我的选择没有错。那是我带孩子参加一个制作小火山的活动，我们需要把苏打粉和白醋混合在一起，发生化学反应后会砰地发出像小火山爆发的声音。我孩子很喜欢这个活动，活动中我问道：“宝贝，我们需要哪些东西啊？”

当然我会期待孩子回答：“我们需要白醋、杯子……”当孩子答对时，我就会表扬他：“答对了，你很棒！我们开始玩游戏吧。”然而突然有一天，我们再去这个活动，我问孩子同样的问题，他看着我说：“妈妈，你需要我呀！”你知道那个瞬间我有多么激动吗？这就是我要的答案，那些标准答案我不在乎了，我要的是我的孩子他自己的成长、他的想法、他给我的所有的这些惊喜——这些我觉得才是最珍贵的东西。所以，我由衷地希望能把 RDI 这个干预方法引进到国内来，介绍给广大家长朋友，因为它能帮助我们的孩子发展出未来真正能够独立生活的能力！

一定要给孩子做‘拼盘’

大家一定要知道孩子的障碍是多方面的，他每个技能的缺失都有对应的疗法，所以给孩子制订干预计划就像搭建拼盘一样。给大家一个思路：一定是将诊断作为出发点。诊断非常重要，是你选择各种疗法的出发点。孩子确诊之后，你需要寻找各方面的专家，比如言语治疗师、特教老师、儿童心理医生等，确定每个专业人士能给孩子提供的支持，为孩子搭建干预拼盘。

我们通过特定的方法帮助孩子发展技能，目标是改变他们的发展路径。那么，干预的场景是什么呢？在北美，一般机构都会派团队到孤独症儿童真实生活的场景中提供支持，所以孩子的干预场景通常是家庭、户外、社区、学校。在国内，孩子的干预场景还多了一个——机构。孩子的发展是动态的，所以在孩子接受干预的过程中，我们要注意每隔一段时间就做一个评估，评估孩子的能力水平、独特优势、当前的挑战是什么……根据评估情况，调整他下一步的干预计划。

当我们选择干预方法的时候应该怎么做呢？那就是一定要制订多学科交互的个性化干预计划。多学科交叉很重要，如果有人跟你说只要用他的方法就行，其他不用管，一定不要相信。个性化也很重要，每个孩子都不一样，都有独特性，要根据每个孩子自己的发展特点制订干预计划，这样才能取得长远的效果。

我一再强调给孩子的干预就像是拼一个大拼盘，孩子的干预环境一定不能只限于机构，因为机构只能陪孩子一段时间，必须将干预融入孩子的家庭、学校、社区等各种环境。目前，在国内我看到一些非常好的现象，有一些很好的机构在尝试把服务延展到线下，延展到家庭。这个趋势我们家长一定要去推动它。另外，我还是强调干预人员一定要经过系统培训，要有资质和经验。我在一些二、三线城市看到一些机构里面的老师居然是曾经的家政人员，我绝对不是说家政人员不好，但是家政人员来做孤独症干预确实有些荒唐，毕竟这是一个非常专业的领域！孩子的父母或照料者、其他家庭成员都应该接受干预方法的培训，尽可能多地参与孩子的日常干预，一起努力，确保实现最终干预目标——提高孩子的生活质量。同时，还要确保孩子的干预效果是可以应用于各种延展性场景的，包括结构化环境和更自然的环境。

拼盘的概念也包含着我们家长的意识。一定不要抱有“只有××才能救孩子”的观点，不管是行为流派、发展流派，还是生物疗法等，都是处在不断探索前进的过程中。

更何况，我们对人类行为的研究，对人类思维的研究，是不是已经到了完整和完美的程度了呢？远远不是。未知的部分远远大于已知。所以，我们凭什么认为，我们的那点已知，就可以拿来作为逆转孤独症这个极端复杂的残障的唯一“点金石”呢？我们应该保持敬畏和开放的态度，持续学习，不断完善给孩子的干预拼盘，这才是我们家长的出路。

一定要了解共患病……

RDI 是辅助孩子、支持孩子发展的干预方法。RDI 能帮助我们更好地解读孩子发出的信号，给孩子呈现一个更加高效的互动环境。所以，我们离不开理解孩子的共患病这个话题。孤独症儿童确实有非常多的共患病伴随。

很多家长面对孩子的共患病问题会感觉很痛苦，像过不去的坎一样。我曾经听到一件让我印象深刻的事情：有一个孤独症孩子，因为从图书馆借的一本书找不到了（这在普通人看来是很小的事情），出现各种情绪问题，折磨了整个家庭差不多有半年的时间。孩子的妈妈想尽了办法也没解决孩子的问题，只好去咨询医生。原来这个孩子是有严重的 PDA（Pathological Demand Avoidance，病理性需求回避）和强迫症，是孤独症的共患病。因为对孩子的这些问题有了正确的认

识，他的妈妈也就不再纠结之前发生的事情了。后来这个孩子在 RDI 的帮助下发展很不错，他的妈妈，一位神经学博士，后来也成为了一名 RDI 顾问。这个孩子成年后跟他的妈妈提起当年图书馆借书的事情。他说：“妈妈，现在我告诉你我当时是什么感觉。妈妈你肯定记得之前外婆给我织了一件毛衣，但是我的皮肤对它极其敏感，穿了两天身上就起了很大一片疹子，导致我还住院好几天。你知道吗？那本书没有还，给我的感觉就像我一直在穿着那件毛衣，无法脱掉！”

你看，如果我们不理解孤独症孩子的共患病问题，谁能想到图书馆还书这件小事会给他带来这么大的伤害呢？我们又怎么可能给孩子一个合适的、安全的、被理解的互动环境呢？所以，我们一定要理解孩子的共患病，多解读他们的反应和想法。

第三章

只有把孩子变成‘机器’才行？

安坐、应名和听指令的背后是什么？

到了机构之后，机构老师就会告诉家长，孩子最重要的三个基础能力是安坐、应名、听指令。家长一听，觉得很有道理，因为有了这些能力后，孩子具有可控性，服从性也高，进入学习状态会更容易，家长也更有安全感。于是家长就拼命训练孩子这三方面的能力，仿佛这三个能力搞定了，孩子从此走上一条康庄大道。然而我想说的是，我们不能一味地只死板地训练孩子这些能力，这不利于孩子整体的干预，还会浪费很多时间。

家长必须真正了解这三个能力为什么重要，如何把它们镶嵌在孩子的发展过程当中，以及如果在训练孩子过程中操作不当会带来什么样的问题。

家长为什么会听从某些机构的建议，一味地让孩子接受高强度的训练、让孩子学会听指令呢？因为家长觉得孩子听指令了才能坐下来好好学习。然而，到底什么是学习呢？不管是儿童发展心理学还是教育学，对学习的定义，都没有涉及服从性这一说。孩子在他一生的学习生涯中，最重要的是具备学徒能力，来帮助他能够独立自主。孩子向他的导师（父母、老师等）学习，将他观察到的内化、整理，伴随大脑结构的改变，最终形成自己的能力，完成从学徒到大师的学习过程，这个过程我们才叫学习。孩子如果只是像机器一样听指令，那不叫学习。

另外，通过商温度的训练。孩子就一定会听指令吗？我遇到太多家长跟我说孩子怎么训练都无法安坐、应名、听指令。很多训练并没有遵循孩子的发展规律去做，训练者也不明白听指令的背后涉及孩子哪方面的能力，最终只能离干预目标越来越远。

在教育史上有一个我认为迄今为止最疯狂的人，叫约翰·华生。他曾经说过这样一句话：“你给我一个孩子，你想让他变成什么样，我就能让他变成什么样。”他用的什么方法呢？那就是高强度的行为训练，他还提出了“条件反射”的概念。他认为婴儿的行为可以通过训练和学习来形成，而非天生的。当时华生将一个9个月大的婴儿小阿尔伯特作为实验对象，也就是在心理学界广为人知的“小阿尔伯特实验”。实验中，华生和其他实验人员通过外在环境和各种刺激，想要塑造小阿尔伯特的行为——对大白鼠产生恐惧。通过高强度的训练，短短一周时间，小阿尔伯特就从对大白鼠没有恐惧到产生了恐惧。后来华生的这项实验被认为是突破人伦和道德的底线的。而小阿尔伯特于6岁时，因为脑积水去世了。

回到孤独症儿童的干预上，可能很多家长都知道一些机构会推荐孩子每周要进行多少小时的干预训练。这种高强度的桌面训练，是正确的吗？这里不得不提一下 ABA 干预方法应用于孤独症干预

领域的开创者伊瓦尔·洛瓦斯在20世纪60年代和80年代分别做过的两个针对孤独症孩子干预的实验。而先后两个实验的结论，很多机构或者早教中心，只是提到了第二个，为什么呢？因为在前面的实验中，洛瓦斯博士做了非常多的尝试，甚至包括比较极端地使用痛感电击作为行为矫正的手段。但是，他发现通过在实验室进行行为干预习得了能力的孤独症儿童，在回归正常生活后，习得的技能却又逐渐退化了。于是洛瓦斯博士时隔几年又做了第二次实验，去除了包括电击在内的厌恶程序，更加强调了学校融合和社会互动的部分，结果实验基本上是很成功的，也就是说孤独症儿童习得的技能在实际生活中得到了很好的泛化。后来洛瓦斯博士总结了第二次实验成功的原因，即他在实验中做的修改，那就是：去除厌恶程序，把干预环境从实验室场景变成了更家庭化和更融合的场景，并且加强了家长的参与度。但是，我们其实很痛心地看着，不仅厌恶程序还在很多 ABA 机构被使用，场景的多元化也没有得到足够的重视，很多家长还觉得 ABA 就是桌面训练，这些问题需要我们通过不断的学习和沟通去改变。

讲到这里，我要特别提到，RDI 一直遵从的是什么呢？就是家长要成为孩子的引导者，修复孩子的学徒能力。家长要成合格的引导者，首先要自己先变成一个学徒，不断学习，让自己从一个对孤独症了解甚少的“小白”变成释通如何引导孩子的“大师”。

孩子理想的训练效果是什么呢？那就是在没有人强制要求他时，他也能表现出之前习得的技能。就拿训练安坐的能力为例。孩子在干预室这样封闭的环境中且有干预师在的情况下可以安坐，在离开了干预室回到家里这样的日常环境也能安坐，这才是理想的训练效果。

同时，在干预过程中，也要给孩子适度的压力。轻微的压力带来的是成长，过度的压力带来的是伤害，长期过度的压力带来的是大脑不可逆的损伤！轻微的压力，就是孩子处在最近发展区时轻推孩子一把，孩子通过努力就能完成事情，这样给予的压力就是轻微的压力。比如，你想让孩子安坐，你可以对他说：“宝贝，我们在这里坐好，一起看电影好吗？”如果孩子配合，那说明这件事对孩子来说是轻微的压力，会给他带来成长。如果孩子必须是老师强制才能安坐，说明安坐这项能力不在他的最近发展区里，如果强制他去做，会给他带来很大的压力，这对孩子的成长是不利的。

我一直建议我们的家长要养育大于干预，任何孩子都不要依靠单一的干预方法，要根据孩子的个体需求，制订一个全面的干预拼盘。

低功能的孩子更适合发展疗法

很多家长跟我说，他们觉得 RDI 对高功能孩子很有用，因为那些孩子其他方面都挺好，就是社会性差或者心智弱，而这些方面正是 RDI 体现优势的地方。

其实我个人觉得低功能的孩子，更加需要发展疗法。低功能的孩子，与他人互动能力很差，互动训练难度大，并且由于语言上的落后，无法有效地表达自己的情绪，这时候如果接受以行为表现为导向的教学，往往会进入越教越封闭的状态，家长也会很崩溃。而且低功能的孩子认知相对落后，理解他人传授的二手经验和抽象概念非常困难，学习会进一步受阻。而发展疗法是针对孩子在中发展缺失的元能力开始进行修复，修复的是孩子的底层能力，强调在生活场景下去塑造体验，让

孩子积累一手经验，从自身的感受中去提炼知识，让孩子的学习有根基，也更有动力，并形成良性发展的趋势。

一定要搭建仿真小环境

孤独症孩子一般都有注意力不好、经常走神的问题。什么叫注意力不好？比如他没有办法把他的思维集中在应该注意到的地方。我们的孩子其实是缺乏选择重要信息，聚焦中心信息的能力的。那该怎么办呢？就是给孩子搭建仿真小环境——在孩子当前能力的基础之上，为他搭建最适合他能力发展的环境。家长应该为孩子提供适合他当前能力的仿真小环境，然后随着孩子能力的增长去向真实环境一步步进发。

我特别喜欢我们RDI课程的王宁老师打的一个比喻。她说，孩子就像一颗弱小的小树苗。我们不能在小树苗还不能经风雨的时候，就直接把它丢到大森林里去，而是要给它一个暖房，这个暖房是最适合它成长的。当它成长到力量已经足够抵御外面的风雨的时候，你再把它转移到外面的广阔天地去。

何谓自我意识？

在陪伴孩子成长的道路上，我们给孩子提供一个支持性的环境去支持他的自主发展，帮助孩子形成自我意识，这才是最重要的。这背后指向的是我们真正要修复的孩子的能力——作为人类学徒的能力，即能作为家长、老师的学徒，通过不断习得，去构建自己在当前社会中生存发展所必需的技能的元能力。具备学徒能力是儿童发展当中非常重要的能力，是孩子成长必需的。如果孩子不具备学徒能力，即使你把他绑在教室的椅子上让他认真听讲，对他真正他都会，他仍然不会与他人互动。的发展也是没有意义的。就算他会拼音、会算数、可以答题，所有的静态知识我遇到过一个孤独症孩子，他在学校里学习能跟的上，但是下课不跟其他同学玩，只是坐在自己的座位上看书、折纸。他没有办法跟别人互动，即使是别人邀请他，他也做不到。他在学校情绪比较稳定，但根本不理解学校这个社交场合是怎么回事，也没有办法处理在学校遇到的各种各样的事情（动态变化）。这样的孩子，尽管会听指令，但是你想他会有好奇心吗？会喜欢探索吗？能与他人分享事物吗？

孩子学习安坐、应名、听指令，都必须镶嵌在他的自我意识当中。孩子要懂得学会应名的意义——代表着后续会与他人有一个互动，代表着他的互动对象有情绪和信息想要跟他去传达。安坐，需要孩子有自主的身体控制能力。安坐最大的意义是什么？那就是在孩子与他人建立共享式关注方面有很大的作用。我在看什么，我要确保你也在看着，我们在共同关注同一样东西，这是安坐真正的意义！同样，没有社会性参照，孩子也不可能完成安坐。听指令的重点也是共享式关注，让孩子明白他和你关注的重点是一样的。你让孩子去做一件事情，而这件事情对孩子来说是有意义的，对孩子的自我认定、能力成长都是有帮助的。听指令不是单纯地训练孩子听指令，而是要让孩子因为与下指令的人有情感联结，愿意为他做事情。

所以，孩子能力的发展，一定是镶嵌在他的发展过程中的。父母首先要在家庭环境里把孩子的能力建立起来，而不是在教室里。曾经有个妈妈跟我说：“老师，我知道我不应该给孩子太多指令，但是他出门就是不跟别人打招呼呀，太尴尬了。如果我在旁边提醒他一句，告诉他该说什么、该如何跟别人问好，他也照做了，你看这不是也搞定了吗？”我告诉这位妈妈，这并不是孩子内在能力的发展，他的表现只是对家长指令的应激反应。

不怕基础差，就怕还在弯路绕

孩子不愿上幼儿园，家长怎么做比较好？我们首先应当了解孩子为什么不愿上幼儿园，是因为他的能力和环境不匹配吗？是有人欺负他吗？是老师对他不好吗？真正的原由可能就是他的能力与环境是不匹配的。那么，我们就要看孩子能力差的地方在哪里？怎样把他这个能力补上去？如果补不上去你一定要他去幼儿园，就会出现副作用，孩子的情绪会不断积压然后在别的地方爆发出来。

我碰见非常多的孩子，已经对于人际互动和融合环境积累了很多的负面记忆，你把他们先从这种危机状态当中恢复是最难的。所以，我们最怕的不是孩子基础能力差，最怕的是孩子已经走了很多弯路。

我们无论做什么抉择，一定不能以牺牲孩子的心理健康和情绪稳定为代价，不能以牺牲孩子对于人际互动的需求和正面体验为代价，否则就得不偿失了。

还是说到孩子不愿意上幼儿园或上学的例子。孩子上幼儿园有压力，比如害怕周一升国旗，这可能需要家长更细致的观察。如果孩子只是害怕周一升国旗，那我们就先暂时周一不让他参加升旗仪式，然后找出他有这种压力的真正原因，慢慢帮助孩子恢复“免疫力”

”，帮他逐渐适应升国旗。

我们大家要明白孩子的很多问题是由于其能力和环境不匹配造成的。现在学校的环境信息变化太多，孩子就很容易焦虑。孤独症孩子本身需要的是一个安静的一对一的支持，需要环境中没有很大的干扰因素。况且他们中有很多有感官信息处理障碍的问题，这样的孩子甚至对环境中的声光电的设备都有益的。一定的要求。为孩子搭建一个适合他当前发展特点的仿真环境，是对孩子最有利的。然而，我们常常没有那么多的选择，很多情况下只能把孩子送进普通教育体系，那么就需要家长为孩子搭建一个相对来说受保护的小环境。比方说家长陪读也好，请陪读老师也好；或者我们为孩子选择一个学业压力没有那么大的学校，班里的人数稍微少一点，老师给的支持会更多一点。

为特殊需求的孩子提供支持的试点学校，我知道南京是每个区都有一所。这种学校中的老师都是经过相关培训的，并且学校的每一个楼层里面都会有一个叫资源教室的地方，可以给这些孩子提供一些专门的学习上的支持。

另外，我们每一位孤独症儿童的家长都需要了解孩子身上可能出现哪些共患病。如果我们针对孩子的干预方法、养育方式不当的话，反而会激发他的共患病。如果干预方法是强迫性的指

令、不脂潮。包括能在日脂的生活丝中、泰育过程当中没有给到一个相应的支持、相应的缓冲、相应的合适方式应对的话，孩子本来没有共患病也可能被激发出来。

那么，我们应该做的是什​​么？一方面提升孩子的“免疫力”，就是他的自我掌控能力和他的耐受力，给他足够的缓冲空间。另一方面是不能让我们的环境压力太大去触发孩子的共患病。孩子很多不好的表现，都是他的能力和当前支持环境不匹配所产生的后果。

孤独症孩子的核心缺陷是什么？

孤独症孩子的核心缺陷到底是什么？应该是动态智能的缺失！

孩子真实的生活环境，就是在动态变化的，充满了不确定性。拥有动态智能的孩子，可以自己评估周围环境，整合周围信息，结合自己的需求做出自我决策。孤独症儿童的核心缺陷是动态智能的缺失。他们不是学不会静态知识，而是缺乏面对这个充满动态和不确定性的世界的​​能力。一个孤独症孩子，可以在小学低年级阶段学会十以内或百以内的加减法、能够认识一些字。但到了三年级时，学习的内容更偏动态，比如数学要学习应用题了，比如语文要考虑文章的中心思想了，这时候动态智能不足就凸显出来，导致孩子对静态知识也学不会了，于是他的压力急剧上升、出现情绪大爆发，然后就会有焦虑、抽动等各种情况。

可想而知，这样的核心障碍是通过听指令能够改善的吗？当然不能！反而如果你给予孩子过度指令，会阻碍他动态智能的发展。于是有家长问我：“那就不给孩子指令了吗？”当然不是，我们要发展的是孩子的学徒能力。什么叫学徒能力？我们当然可以给指令，但是我们给的指令不是给孩子一个静态的对错标准，而是在孩子自主探索的过程中，给予安全性的保证和方向的引导。我有我的内心需求，我有我的主观需求，我有我的内在动力，我想成为一个大师，在这个过程当中，我不断吸取我需要的能量，转化成我自己可以使用的东西，同时不断地实践去提升我的能力，这才是学徒该做的。这就需要我们家长首先了解孩子当前的能力，然后站在孩子身前一步去引导。

我们举个例子：你想要教孩子游泳，你要先判断孩子当前的能力是怎样的，他可能只能站在一个水刚没过膝盖的位置，那么你就要站在孩子身前一步，站得比他稍微深一点，然后给孩子一些支持。你要把手伸给他，同样你可以发出指令，但是你这个指令的目的不是让孩子去做到你想让他做到的事待，而是你给他一个合适的支持，让他明白下一步在哪里，剩下的是他自己决定要不要伸出手来握住你的手往前迈出这一步。如果孩子没有做到，那么你就再靠近孩子一点，直到孩子愿意自己伸出手接受你的帮助向前迈一步。

我们是孩子的导师，是孩子的引导者和支持者。我们可以给孩子一个框架、一些限制，但这些框架和限制的目的都是不断帮助孩子一点一点往前走，使他时刻体会到胜任感和成就感，在这个过程中将所学的东西内化。唯有这样的一条路走下去，我们才能期盼他有独立自主的那一天。

第四章

我的孩子过了黄金期就没救了？

不要纠结所谓的黄金期

孤独症孩子开始干预的年龄越小效果肯定是越好，但是我们要知道大脑终身可塑！所以，不要纠结所谓的黄金期。我一直很不赞成所谓的几岁是孩子发育的黄金期这样的说法，即使是典型发育的孩子，每个人的发育也不一样，像孤独症孩子这样非典型发育的孩子更别谈有什么黄金期了。孩子从婴幼儿逐渐成长起来，大脑结构是从简单到逐渐复杂，大脑是在不断变化和发育的。

现在大家普遍得出的结论是基因在孤独症发病中有重要作用。基因很大程度上会决定我们的大脑如何发展。生长的环境也会影响孩子的大脑。在原始丛林里面长大的孩子和在大城市长大的孩子大脑结构的发展肯定是不一样的。同时，饮食、运动等因素都会影响孩子大脑的发展。我们在平时生活中，要想办法为孩子打造适合他们发展的仿真小环境。

大脑的复杂程度远超我们现在所有的认知，大脑不同的部位负责不同的功能。以大脑对信息的处理速度为例，大脑的信息处理速度一直到18岁之前都是在持续不断进步发展的。大脑对于书面语言和口语的处理能力直到六七十岁还在继续发展。人的视觉记忆能力在35岁之前一直都是发展的。大脑的各个功能区块有自己的发展规律，跟执行功能相关的大脑边缘系统也是发展到25岁才基本发育完善。

对于孩子，真正的教学过程是你把信息传达给孩子之后，孩子在自己的大脑里加工处理，他把接收过来的知识融入到自己的认知体系当中，经过消化、吸收，经过不断的练习和在不同场景下的尝试后内化为自己的东西，这是没为，重要的！

孩子听指令做了你让他做的事情，这只能说明他拥有听指令的能力，但听指令的能力绝对不等同于学习能力。学习能力是接收到了这个信息，他可以融入到自己的知识体系当中去并且向你不断地提问题。他把学到的内容在不同的场景下进行关联，把这种短时记忆、长时记忆、感受记忆联系在一起，储存在自己的海马体里，这叫学会了。

家长千万不要因为所谓的黄金期而拼命地给孩子施加压力。孩子在高压状态下，缺乏安全感，觉得自己不被理解，就不会用正确的思维去思考和做事情了。

很多机构都会告诉家长别让孩子错过干预黄金期，否则就来不及了，我认这完全是在贩卖焦虑。

一定要关注‘窗口期’

这里我想为大家强调一个重要概念——“窗口期”。我们需要关注的是孩子的窗口期。要理解什么是窗口期，家长需要明白这个概念涉及的到底是什么。我们知道，孤独症儿童的学徒能力是缺失的。他们常缺乏内在的动力，获得的能力常不能泛化到不同场景中。这就需要我们家长为他们不断创设仿真小环境，一直给予支持，帮助孩子完成从量变到质变的进步过程。

在这个量变到质变的过程当中，家长最应该关注的是给到孩子什么样的支持。这个时候我们一定要确保给予的外界环境是支持性的，而不是打击性的。比方说我们的孩子在攀爬，他爬到最后一个点了，这个点可能稍微高一点，当贝，你真棒！”还是说“危险！你给我下来！”孩子伸出手准备去够上面的栏杆把自己拉上去的瞬间，请问你在旁边是说“宝家长经常会关注孩子在某段时间状态好不好。比方说，家长发现孩子最近好像灵活了很多，突然开窍了，这其实是孩子之前一点点进步的积累导致的；或者发现孩子最近总是不听话；或者孩子对某一项事物特别关注，想要去探索。这些都说明孩子处于窗口期。这个时候，家长要给予孩子的是全方位的支持而不是打压。

另外，我还想谈谈孩子自我意识的发展。当孩子处于自我意识飞速发展的时期，有时候会表现为尝试控制身边的人和物。就拿我的大儿子为例，有一段时间他总是会说：“八有你不要睡在这个沙发上，你要睡在那个地发上。弟猪你不要出去玩你要……，妈如婆……”还有的孩子，之前家长跟他做桌面练习时很听话，可忽然变得不听家长指令、反抗桌面练习了。这些其实都是孩子自我意识发展的萌芽。如果我们没有敏感地捕捉到，就会影响孩子的进步。

还有一些表现，也提示孩子可能进入了窗口期。例如，当你发现孩子语言大量增加时或者他很想组织语言但是会有前言不搭后语的现象时。我的小儿子曾经上过乐高兴趣班，每节课结束后老师都会为孩子们录一个视频，讲解今天做了什么。我的小儿子一开始总是落后于其他小朋友，能说的语言很少，内容也很简单。可是有一天，我发现他在讲解的时候，试图组合不同的词语，而且总是卡住，然后就只能不断重复开头的几个字，像复读机一样，让人听上去很难受。当时我就发现，这其实是他正在进行思考，或者说，他在从完形语言向逻辑语言过渡。于是我给了他充分的等待，从来不会打断他或者催促他，等他过了这个坎之后，他的语言丰富度一下就上了一个台阶。

干预窗口期我还想补充另外一点就是，当孩子处于窗口期的时候，可能出现情绪问题。所以，这个时候家长尤其要注意不要给孩子太多压力，尽量为他创设轻松一些的环境。

如何捕捉和抓住窗口期？

对于家长，怎么样才能够去觉察和抓住孩子的窗口期呢？其实最重要的是家长要有敏锐的观察力，观察和明白孩子行为背后的原因。我们一直在讲最好的亲子互动是发接球一样的互动，是你和孩子维持沟通之“球”在空中不落下来。孩子处于窗口期时，相当于孩子在发“球”，我们要能把这个“球”接住，要像雷达一样敏锐地观察孩子呈现出来的状态。

作为家长，我们一定不能把所有的眼光都放在孩子身上。无论是教育也好，干预也好，除了看向孩子，一定要看向自己。我相信有很多家长会发现，随着孩子的进步和长大，自己变得越来越焦虑了。为什么呢？请想一想，从孩子确诊那一刻开始，我们自己成长了多少，我们的认识有没有逐渐提高。家长会焦虑，觉得越来越难，一方面是把孩子跟同龄孩子比较，发现差距越来越大，导致内心的失衡；另一方面，就是目标感太强，总想把孩子塑造成自己想要的样子。孩子2岁的时候你可以压制他让他安坐；3岁的时候你可以给他一颗糖让他做很多事情；4岁的时候你可以跟他说“妈妈好喜欢你，宝贝你好棒啊！”……以这样的方式来让他做很多的事情；七八岁之后你发现做不到了，你觉得自己对于孩子的控制能力越来越弱，而你的焦虑可能会越来越多。所以，家长一定要向内看孩子的发展特点，而不是一味地管理，要给孩子正确的支持。这个我觉得非常重要。

一直在路上，一直有希望

你可能会看到，在孤独症这个圈子里，大龄孩子的家长很少发声，我们很少看到大龄孩子发展情况的信息。这里面有很多原因，但有一个很重要的原因，就是孩子从接受干预到学龄阶段，情况仍然不是很好，很多家长可能会选择得过且过了。

我们对孩子一定要有信心，对大龄孩子的干预也不能放弃。因为在孩子整个成长过程中，我们要恢复的是父母和孩子之间的联结，是健康和正确的亲子关系。孩子和父母之间良好的联结状态，能支撑我们长久地把这场马拉松跑下去，才能给孩子一个更加长远的支持。

我们家孩子给我带来了非常多的快乐。他们经常会出一些状况，但是我理解他们，因为这是他们身上的特质。但如果某一天我觉得特别累，我也会选择“放养”，等我心情状态好了，再打起精神来跟他们往前走。我始终坚定的一个原则是我们要生活，我不能以牺牲任何一个人或者牺牲生活质量为代价。只有这样，我们才能给孩子提供最优的互动环境。

我的孩子是孤独症，他会好吗？

《深夜妈妈谈》的创办初衷

我们的直播叫《深夜妈妈谈》。我们希望通过这样的直播，给大家一些建议、一些帮助，也分享我们作孤独症家长的心得，让这个群体能感到温暖。我第一次做直播的时候，当时有一个妈妈是我们的老朋友，她说过一句话：“我们这样的家庭，就好像生活在地下的鼯鼠。从孩子确诊的那一天开始，我们仿佛把生活从地上转移到了地下，我们完全跟之前阳光下的生活隔离了。地面上阳光下的家长永远不知道我们的生活方式，而我们可以扒开泥土向上去看阳光下的他们是如何生活的。”当时听完后，我心里真的很难过，我觉得她说得太贴近现实了。所以，我们一定要明白，我们这个团体是要互相抱团、互相取暖的，我希望大家离开直播间的时候，不仅学到了知识，还感觉找到了组织——原来妈妈们可以这样生活，孩子们可以那样生活，这是我们做《深夜妈妈谈》的初衷！

用大龄案例来解读‘一日孤独症，终身孤独症’

提到“一日孤独症，终身孤独症”这句话，有些人可能会愤怒、会觉得很灰心，或者觉得我是在贩卖焦虑。但我个人对这个说法还是坚持的。因为孤独症孩子的障碍确实是现实存在的，随着孩子的成长，这种障碍会不断积累，当然也有可能改善，但是孤独症的特质可能终身都会陪伴他。帮助孩子拥有一个独立自主、有价值的人生，才是值得我们去探讨的！

为什么关于孤独症共患病的研究这两年越来越多了？因为大龄孤独症孩子越来越多，能够为自己发声的也越来越多，我们得以更多地了解他们面临的障碍，去体会他们的生活，去看看他们的世界是什么样的。

我曾经跟一些大龄孤独症孩子沟通，问他们问题，他们的回应让我越来越清楚地意识到孤独症是神经系统多样性的一部分，他们不是残次品，而是一群有不同特质的人。

这些孩子会让你看到希望不是只有一个样子，未来也不是只有一种颜色。在我眼里，他们都是非常优秀的人！

我曾经分享过一件让我非常感动的事情。我家老二有一次参加一个社交技巧的培训项目，内容设置很有意思，是大孩子带着小孩子到处去玩。这个项目里所有的工作人员，包括行政人员和带小孩子出去玩的大孩子们，都是孤独症人士。

那天我带着我家老二去到活动地点，是一个激光闯关的游戏室。大家可以想象一下，那里环境非常嘈杂，人也很多。我家老二是个有多重诊断的孩子，不仅有孤独症，还有多动症和感官信息处理障碍，他一进去就开始呈现各种信息过载的表现，来回跳，并且抖手抖脚。

这时候，迎面走来了两个大孩子，其中一个看看我家老二，又看看我。然后指着老二问我：“他是孤独症？多动症？”

我笑笑说：“是的啊。”

然后这个大男孩露出了很得意的笑容，拍着自己的胸脯对我说：“我就知道，因为我和他是一样的。我也是孤独症和多动症。”

他又指着旁边的另一个大男孩说：“喏，他也是。”

两个大男孩一边说着，一边走过来拉老二。老二这时候也不再蹦蹦跳跳，直接握住两个哥哥的手，三个人就这么牵着手走进游戏室玩去了。老二还没忘记回头冲我说了句：“妈妈一会儿见。”

我在那一刻热泪盈眶。这是我见到孤独症孩子最好的状态——了解自己，做自己，并为自己骄傲。

所以，终身孤独症绝对不意味着我们的孩子是“残次品”，我们的干预也绝不意味着要将孤独症从他们身上“剥离”，而是支持我们的孩子即便带着这些特质，也依然找到自己的价值，拥有自己的人生。

我们的最终目标是什么？

我们这一章的主题是“我的孩子是孤独症，他会好吗？”那么我想问，我们心目中的好到底指什么？到什么样的程度呢？是能上幼儿园或者能上普通小学不用陪读，或者能和其他小朋友一起玩？坦率地讲，当我的孩子确诊后，我第一次跟医生聊时，我的希望也是这么简单啊！

希望孩子未来能够上学、有一份简单的工作、有几个朋友，我难道错了吗？我要求不高啊！我特别喜欢王宁老师的一段话，她说：“我们的孩子最终目标是要能潜伏下来，带着特质过普通人的生活，能够正常上学、独立生活，有一份安身立命的工作，隐藏在普通人里面就行。”其实普通人的生活并不容易，度过青春期、获得工作、维持亲密关系、在社会上独立生活……这些一点都不容易，对于孤独症孩子来说更是很大的挑战，就像是外星人要找到能够在这个地球上生活下去的规则和方式一样。

两件值得关注的事情

【一个与学校奖惩机制抗争成功的案例】

美国有一个联盟，是由很多在学校体系当中专门为问题儿童工作的作业治疗师、言语治疗师以及一线教育工作者发起的联盟。

主流学校的教育体系一定是主要针对典型发育孩子的，一切都以维持学校正常运行为准，所以对于特殊儿童出现的问题行为，多是采取约束和压制。例如，如果孩子有不好的行为，有可能让孩子从班级离开；或者如果孩子表现好，就给孩子代币，一天存满了3个代币孩子就可以得到奖励如玩iPad，没有存到3个代币就会受到惩罚。他们采取这种方式听起来很有道理，是不是？但是，这个联盟的成员提出，学校的这种方式是完全错误的！教育的目的是帮助孩子的自我控制能力得到发展，而学校这样的约束和压制不能让孩子自我管理的能力得到发展。事实也证明，被约束和压制的特殊儿童并没有在学校越来越表现出好行为，反而他们跟学校、老师之间的安全感和连接性被逐渐破坏掉了。

有些孩子可能一开始的时候只是表现出一个小的问题行为，但是压制之后会变成一个巨大的问题行为，然后孩子的整个自我管理系统、内在需求系统和心理状态完全崩溃！后来，这个联盟向美国的最高法院提出诉讼，要求美国各个州的教育部把这套约束和压制的体系从整个学校系统里面完全剥离。目前，美国马里兰州已经把这套体系从学校系统里完全剥离掉了，那里的学校的教育工作者认同孤独症儿童的表现是神经多样性的体现。

这是最近在美国整个教育体系发生得非常大的一件事情，我其实很感动。

他们走了一条更加艰辛但对我们的孩子来说完全有效的道路，也勇于站出来跟整个教育体系的问题做斗争。

【Stop shock—停止电击】

大家可能听说过电击疗法。你相信现在这个年代还有机构对孤独症孩子用这种方法纠正他们的行为吗？是的，真有这样的机构，这个机构叫JRC，臭名昭著，从20世纪60年代开始用电击打孩子，孩子一旦做出他们觉得不合适的行为，就用电击打孩子。美国的FDA把他们的机构给禁了，说不可以再这样对待孩子了，这个机构上诉到美国最高法院说他们使用的不是一个方法，他们使用的是一种医疗器械。FDA非常被动，因为FDA没有资质去审核一个医疗器械的资质，所以这个机构硬生生地把美国FDA禁令给推翻了，不仅推翻了，而且在ABA国际年会上，他们还作为嘉宾去宣传他们的电击疗法，直到多方抗议才作罢。

美国的孤独症群体曾经游行对这个机构提出抗议，这个机构还把抗议者告上了法庭，说他们是宣传不实。

我把这两件事情合在一起跟大家讲，意思是当你的孩子出现不符合你要求的行为时，你要为孩子的成长提供什么样的支持环境，最终帮助孩子发展出自我管理的能力，而不是有一天把孩子送上电击台。

究竟要不要百米冲刺？

有很多家长说：“我下定决心以百米冲刺的行动力来给孩子干预，以达到最佳效果！”或者，“我孩子现在5岁，我砸锅卖铁给他干预3年了，就想让他能够正常入学。”其实大家一定要明白，这是一场马拉松，不仅是我们的马拉松，也是孩子的马拉松。孤独症儿童的干预绝对不是一件百米冲刺的事。

我们一定要学会分配我们的精力、时间，以及努力调整好心态，尤其是中国家庭的家长。因为中国人非常讲究共性，“与众不同”在我们的传统教育中不是一件好事，家长希望自己的孩子跟传统教育是相关的，如果孩子没有办法进入到主流教育就认为是不好的。这种心态会让家长产生非常大的焦虑。可是我们要知道，这是不现实的，我们的孩子可能一辈子都会带着孤独症特质，他的这种特质会随着环境中支持力度有效或者不够有效而产生非常大的变化，所以我们要长期陪伴孩子的心态。在这个过程中，我们要把这种跑“马拉松”的能力延展到孩子身上，让孩子未来可以独立自主。当我们有一天不在的时候，他们能够把这场马拉松继续跑下去，这个是我们要去做的！如果你百米冲刺的话，你抱着一个短线目标，一旦这目标达不到，你就跑不下去了，你就会陷入很崩溃的状态，而你的崩溃状态会直接影响到孩子！

随着孩子的不断发展，家长作为引导者的能力也在不断地提升，我们越来越理智、越来越能够透过现象看到事物的本质，我们更加能够非常好地帮助孩子解决他们成长过程当中遇到的问题，那么我们孩子的能力也会随之提升，他们的发展也会得到修复，所以这是一个父母和孩子互相促进的正向循环。如果你采取百米冲刺的心态，反而会让你和孩子都陷入负向循环。我们不是跟在孩子身后，而是始终站在孩子身前一步去引导他往前走。

第六章

条件反射型还是自我驱动型——你想要什么样的孩子？

你让孩子靠什么面对未来的不确定性？

曾经有所谓的大咖家长说过，对于孤独症孩子来说，你能够给他的最好的礼物就是形成一系列的条件反射，让他极其听话，这样家长不在了，他们不会给别人添麻烦，可以过得很好。

这让我们不得不思考，孩子干预的终点到底是什么？是把孩子训练成条件反射型的极其听话的机器？还是让孩子知道自己该怎样生活、真正地知道自己想要什么，成为一个能够完成自我驱动、自我满足和自我成长的人？

我跟大家分享一件事。有一天我们家老二滑滑梯时磕着了“小鸡鸡”，整个下腹开始绞痛。他捂着肚子从楼梯往下滚，当时我就非常着急，因为他有很严重的内感官失能的问题。典型发育的孩子，是有解读自己生理信号的能力。比方说，你觉得你紧张了，你怎么知道你紧张了？你的身体会告诉你。当你在准备考试的时候，你只要一想到考试，你的手心会出汗、浑身肌肉会紧张，所有的这些生理信号传回你的大脑，大脑做了解读，你了解了自己为什么会有这种反应，于是你不会觉得恐慌。可是孤独症孩子缺乏这种能力。所以我家老二是没有办法准确地告诉我哪里不舒服，因此对这种外伤的判断对我们家来说，是一件非常有挑战性的事情。

我当时非常着急，那会儿正好我们的家庭医生已经下班了，我只能带着孩子去急诊。可当时还在疫情期间，一旦去急诊就可能被隔离，非常麻烦。于是我赶紧给同事发微信，告知家里的突发状况以及可能会对第二天我们平台的直播产生的影响，然后一边带着老二去医院一边随时和同事沟通第二天工作的安排。

讲这些的重点是什么？我想说的是，生活中很多事情，不可能完全按照你想的方向去发展，我们要对不确定性有心理准备。而且很多不确定性是一环套一环的。就像一位名人说的，这个宇宙当中最大的确定性就是充满了不确定性！

动态智能是面对不确定性的能力

大家想一想，我们把孩子训练成条件反射型，让他碰到一种情况他就知道该怎么办，这个设定可能吗？我当时给孩子从行为疗法转到发展疗法的时候，就是因为遇到了瓶颈。当时，我把每一件事情都拆得很细致地教给孩子。就拿教孩子出门到对面超市买东西这一件事，我会拆得分特别细

致，我告诉孩子过马路红绿灯是什么样子的，过了马路之后要怎么去买东西、要怎么去付钱，我给他全部都训练好。

可是我坐在家我我就在想：我全都教会他了，他都记下来了，等于我可以放心地让他自己出门了吗？仍然不是！按理说我有这么完整的计划，我在怕什么呢？我突然明白我怕的是不确定性！我不知道他从家里出门到超市这个过程中他会发生什么。我的计划再完整，也无法预测外界的各种不确定性、是否有各种潜在危险…于是，我开始有些恐慌，我意识到我没有办法把世界上所有的事情都教会孩子如何去做，那到底在我的教育中缺失了什么呢？缺失的这一部分一定是和帮助孩子如何面对外界的不确定性有关，一定是帮助孩子能动态地灵活应对各种问题的。于是我开始寻找答案，最终我找到了RDI，因为RDI告诉我孤独症孩子的核心障碍是动态智能的缺失，动态智能是孩子面对不确定性的能力！

我希望我的孩子能实现自驱型成长，面对不确定性能够自发地不断“生成”应对办法，真正成为自己的主人——这才是我们应该为孩子设定的干预目标！

用一个故事解读动态智能

动态智能是什么？是我们能应对所有不确定性的能力。

小红书最近有一个非常火的帖子，题目叫做“这种松弛型的家庭太让人羡慕了”。帖子的故事讲的是有一家人准备出国去玩，父母突然发现二宝（妹妹）的签证出了问题，于是妈妈就陪着二宝回家了，由爸爸带着老大和简单的行李继续上飞机到目的地去玩。在整个过程当中，这一家人情绪都很稳定，没有任何的埋怨。妈妈拉着妹妹的手说没关系的，然后跟爸爸说你们玩得开心，爸爸也非常淡定地跟老大很开心地上了飞机。

这个帖子引起了网友的热评，评论区有人写到“这样松弛的家庭是我一生的向往！”。我想，这个家庭的松弛感一定来自父母的底气，来自父母和孩子都拥有的动态智能！这就是我想要跟大家分享的，我们生命当中有那么多的不确定性，所以我们最终一定是要培养孩子的动态智能，它是我们的最终目标！

同样的，孩子的安全感来自哪里呢？我想应该是来自我们的家庭，来自父母对孩子的爱。家应该是孩子温暖的港湾，是孩子遇到不开心的事情想回到的那个地方！如今，有的家长还赞成用武力压制孩子，认为孩子不好是因为打得不够，这样的家长教育出来的孩子，很容易拥有不健全的人格。家长有这种表现也是内心极度无助、无能的表现，他们面对其他人的眼光和歧视，倍感压力，于是就采取一些极端的方法压制孩子，而不从自身找原因。

无条件的爱和溺爱的区别是什么？

到底什么叫溺爱？什么叫无条件的爱？当我们说要无条件地爱孩子时，很多家长心里的安全感就崩塌了，说那不就是溺爱了吗？不就是惯坏孩子了吗？大家想一下，无条件的爱的第一个原则是

什么？是我们从孩子的角度出发，肯定他的感受，看见他的感受，确认他的感受，让孩子明白“妈妈是懂我的”

第二个原则是，我们要思考给孩子无条件的爱和满足表面行为的区别。比方说大冷天孩子想吃冰激凌，那这个时候，我们可以不满足他的要求，但是不能否定他对于冰激凌的喜欢，更不能将他对于冰激凌的喜欢定义为“不良习惯”。即便不满足要求，我们仍然可以让孩子感觉到“爱”。

第三个原则是，无条件满足是给孩子他这个年龄段应该能够去承担和拥有的自由度，而不是剥夺孩子的控制权和自主权。大家一定要把“无条件的爱”跟“溺爱”分开，我觉得最根本的点就是你到底是从哪里出发的？你是站在孩子的角度上出发的，还是站在你自己的角度出发？无条件的爱的出发点是看到孩子的需求，而溺爱则是孩子想怎么样就怎么样，二者是有显著区别的。

过度指令、过度补偿.....

过度指令也好，过度补偿也罢，都是我们家长的一种内心的状态（如担心、焦虑不安）的体现。过度指令是什么？“宝贝，我们今天一起来洗个碗好不好？你把碗拿起来，不是这样子拿的，我跟你讲你放下来，你要这样捏着边，不拿好碗会掉的你知道吧？你把碗摔了你还怎么吃饭啊？哎呀，算了，你走开，我来吧。”这个就是过度指令，孩子每一步都还没有开始做之前，你的指令已经到了。过度补偿是什么？“来宝贝，你今天跟妈妈一起来洗碗好不好，我给你拿着，小心点没事，不对我跟你讲这个水呀，一直开着会浪费很多水的，妈妈帮你关了好吧？我给你把擦碗布准备好了，你就把它拿着擦一下就可以了啊。”

这叫过度补偿。

这两种方式都是在侵占孩子的自主空间，侵占孩子的自主权和他的成长。过度指令和过度补偿的结果是孩子无数次地被你否定，觉得自己做不到。我们的目标是希望让孩子体会到自主成长背后的心智动力，一定是觉得自己可以，这会驱动孩子最终的成长，也会帮助他学会更多的技能，最终可以面对成长道路上遇到的各种不确定性。

我其实跟很多家长聊过，带孩子一起做面包、烤蛋糕是非常棒的亲子活动，做吃的会让孩子产生直接的成就感。我们家长带孩子做之前想得特别好，但一旦开始做就会听到“面粉你别糊得到处都是”“你搅料的时候慢点行吧”“看看这面粉到处都是，我来擦，你边上去吧”。所以，我们家长要时刻意识到，当下的这个决定，当下你在说的这件事，你的这个动作，是在告诉孩子你觉得他可以还是你觉得他不行。我们一定不要刻意地去打压孩子。

如何让孩子感觉到自己在成长？

我们在陪伴孩子成长的过程中，最重要的是让孩子能够感觉到自己在成长，能不断学习新的东西，想要探索这个世界。这需要我们家长一定是要把路铺到孩子脚下去。如果你站在自己的角

度，把路铺在自己脚下，你自己往前走孩子在底下看着，或者被你拖着被你拽着，他能成长吗？他成长不了！你的一句话、一个眼神、一个动作，都会影响到孩子。

大家千万不要怀疑一个眼神、一句话，对孩子有那么大影响吗？是的。对于孤独症孩子来说，我们眼里的一件小事，反而在他那里可能就是一件大事。

我们家老大有段时间很怕黑，他早上起来第一件事情是先去把房间的灯打开，我老公就会问他：“大白天开什么灯，你要怕黑把窗户打开不就得了吗？”我老公其实就说了这么一句，也没有责备的意思，可我们家老大就有被批评的感觉，他就想了半天，然后自己把灯关了。我老公想帮他把窗户打开，他跑过去把他爸打开的窗户再关上，他自己再打开一遍，然后回头跟他爸爸说“我自己来”。

我后来跟我老公讲，老大在意的并不是这件事，他在意的是你是不是在肯定他，因为爸爸当下的语气可能重一点，如果轻一点产生的效果是完全不一样的！所以，你觉得是给孩子建议，但孩子感受到的可能是指责，他往往会把一件小事放得很大。这一点我们家长一定要注意！

RDI 教给家长的.....

RDI 对于我来说最大的好处就是，在生活当中时时刻刻都有帮助孩子去自主思考、去动脑子的点。我们最终期望孩子的发展一定是他不断地运用自己的思维，因为只有他不断地运用自己的思维、不断地锻炼自己的思维能力，他才会动脑筋，才能应对各种不确定性。

我们前面讲的条件反射是什么？是你给他一个结果他照着走就完了，那么他永远不可能应对面临的不确定性。我们要努力让孩子在生活当中时时刻刻都要处在有结构的仿真小环境中，让孩子愿意主动去动脑筋。RDI 帮助我们不断培养孩子的胜任感，一步一步训练孩子的思维能力，让孩子逐渐地独立起来。